Nota técnica: integración de datos públicos sobre desabastecimiento de medicamentos y mortalidad prematura en Bogotá (adultos de 60 a 69 años)

Equipo TINTOS · Bogotá DataJam 2026

1. Utilidad de los datos

Se integraron 5 fuentes del Portal de Datos Abiertos de Bogotá: el listado de desabastecimiento de medicamentos (Secretaría Distrital de Salud) y cuatro conjuntos de mortalidad prematura (cardiocerebrovascular, neoplasias, respiratorias crónicas y diabetes). Permiten comparar la carga de mortalidad de 60 a 69 años de cada grupo de enfermedad con la presión de desabastecimiento de sus medicamentos prioritarios, y ver en qué localidades se concentran las muertes. El orden de los 4 grupos coincide en ambas medidas (cardiocerebrovascular primero), pero con solo 4 grupos la relación es descriptiva.

2. Disponibilidad, actualización y calidad

- El listado de medicamentos es una foto de un solo mes (agosto) y ninguno de los 237 registros trae fecha de cierre: no se puede calcular duración ni evolución.
- El campo “Estado” mezcla desabastecido, en riesgo, en monitorización y no desabastecido. Solo 32 de 237 registros (13,5 %) están desabastecidos, y el campo tiene un error de digitación.
- La mortalidad viene en casos, no en tasas, porque no hay denominador poblacional. 2026 es un año parcial y el grupo cardiocerebrovascular solo trae ese año. Hay 24 casos sin localidad.

3. Retos de integración

- No hay llave común: los medicamentos no tienen localidad, EPS ni edad. El cruce se hizo por grupo de enfermedad a nivel Bogotá, y la lectura por localidad es solo de mortalidad.
- Los medicamentos se asignaron a los 4 grupos por palabras clave en la indicación. El 54,4 % de los prioritarios queda en ellos y el resto son otras enfermedades crónicas. Algunos registros tienen indicaciones inconsistentes.
- Medicamentos usa coma como separador y mortalidad punto y coma. Las edades vienen en grupos de 5 años: se acotó a 60-69, y los archivos incluyen también grupos de 70 años o más.

4. Limitaciones

- Relación descriptiva, no causal.
- Rango de edad 60-69 años, no 60-70: el último grupo disponible dentro de mortalidad prematura es 65-69.
- Año de referencia parcial. “Prioritario” se definió como prioridad en salud de enfermedades crónicas o cáncer, y la clasificación de medicamentos es decisión del equipo.

5. Recomendaciones

1. Priorizar el monitoreo en las localidades con más muertes prematuras de 60 a 69 años (Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar en 2026 parcial) y en los grupos cardiocerebrovascular y neoplasias.
2. Publicar el listado de desabastecimiento con fecha de inicio y de cierre, con histórico mensual y un campo separado para el desabastecimiento efectivo.
3. Incluir localidad o EPS/subred en el reporte de medicamentos, para poder cruzar territorio.
4. Publicar la mortalidad también como tasas, con población y con todos los años de cada grupo.